

Рефераты по темам:

1. Современные подходы к витальной терапии пульпы;
2. Сравнительная оценка эффективности эндодонтической ирригации средствами на основе растворов гипохлорита натрия.

Научный руководитель:

Луцкая Ирина Константиновна, доктор медицинских наук, профессор.

Сделано вр. стоматологом Акбари Бехруз Али

1. Современные подходы к витальной терапии пульпы.

Современные подходы к витальной терапии пульпы направлены на сохранение жизнеспособности зуба и предупреждение эндодонтического лечения, которое не всегда бывает полностью успешным. Основные методы включают не прямое и прямое покрытие пульпы, частичную и полную пульпотомию, а выбор тактики зависит от точной диагностики, состояния пульпы и наличия необратимого воспаления.

Суть витальной терапии

Гиперемия пульпы — это ранняя, обратимая форма воспаления, при которой возможно сохранение ее функции и структуры зуба. Показаниями к консервативному лечению являются гиперемия пульпы, случайное точечное вскрытие полости зуба и перелом коронки с обнажением пульпы. Противопоказанием служат все необратимые формы пульпита.

Диагностика

Перед лечением важно собрать подробный анамнез боли, оценить реакцию на температурные раздражители, провести перкуссию, электроодонтодиагностику и рентгенологическое исследование, при необходимости КЛКТ. На практике также учитывают характер и длительность кровотечения из пульпы, если нет более точных молекулярных тестов.

Материалы для лечения

Чаще всего используют препараты на основе гидроксида кальция и МТА, которые обладают антимикробным действием и стимулируют формирование репаративного дентина. МТА в последние годы все чаще предпочитают из-за хорошей герметизации, прочности и более выраженной эффективности при прямом покрытии пульпы. Цинкоксида-эвгенольный цемент может оказывать антисептический и обезболивающий эффект, но при непосредственном контакте с пульпой способен вызывать воспаление и мешать полимеризации композитов. Адгезивные системы применяются спорно: их эффективность обсуждается, так как они не обладают выраженным антимикробным действием.

Методы лечения и прогноз

К консервативным подходам относятся не прямое покрытие пульпы, избирательное и пошаговое препарирование, прямое покрытие, частичная и полная пульпотомия. Все процедуры следует выполнять строго в асептических условиях, с коффердамом, а для гемостаза и дезинфекции чаще используют гипохлорит натрия или хлоргексидин. Оценку

результата проводят через 6 и 12 месяцев, а затем ежегодно до 4 лет; успешным считается отсутствие боли, периапикальных изменений и признаков резорбции, а у незрелых зубов — наличие признаков апексогенеза или апексификации.

2. Сравнительная оценка эффективности эндодонтической ирригации средствами на основе растворов гипохлорита натрия.

Цель исследования — повысить качество ирригации при эндодонтическом лечении за счет применения растворов гипохлорита натрия разной концентрации. Для оценки лизирующего действия были изучены два средства: «Дентисептин-3,0» и «Дентисептин-5,25». В каждой группе выполнено по 10 наблюдений с использованием экстирпированной пульпы зуба.

Гипохлорит натрия считается одним из наиболее эффективных ирригантов в эндодонтии благодаря антибактериальным и тканерастворяющим свойствам. Его действие связано с сапонификацией, нейтрализацией аминокислот, образованием хлораминов и высоким рН, что обеспечивает разрушение органических тканей и подавление микрофлоры. При этом более высокие концентрации повышают эффективность, но и увеличивают риск раздражения периапикальных тканей.

В исследовании лизирование пульпы при использовании «Дентисептина-3,0» происходило за 6 минут 48 секунд, а при применении «Дентисептина-5,25» — за 3 минуты 54 секунды. Таким образом, средство с 5,25% гипохлоритом натрия оказалось почти в 2 раза эффективнее. Авторы отмечают, что именно эта концентрация обеспечивает более быстрое растворение тканей пульпы.

Вывод: для растворения пульпы при лечении пульпитов и снижения риска эндодонтических осложнений целесообразно использовать средство на основе 5,25% раствора гипохлорита натрия в течение 4–5 минут контакта с тканями корневого канала.

Литература

1. Юдина Н.А., Манюк О. Н. Стоматологический журнал • 4 • декабрь • 2025 - С. 209-212.
2. Савостикова О.С., Манак Т.Н. Современная стоматология. - 2021. - №2. - С. 77-79.